

CAPÍTULO 6.5

Ajustes de Insulina

PERFIL EUNACOM 1.04.1.005

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Ajuste de Insulinoterapia

Principio fundamental

TABLA 6.5.1: TIPO DE INSULINA VS DETERMINA LA GLICEMIA...	
TIPO DE INSULINA	DETERMINA LA GLICEMIA...
NPH / Glargina (lentas)	Pre-prandial (varias horas después)
Cristalina / Ultrarápida (rápidas)	Post-prandial (2 horas post-comida)

Cuándo ajustar

- Si hay **hipoglicemia** → bajar insulina o agregar colación
- Si hay **hiperglicemia persistente** (HbA1c > 7%) → subir la insulina correspondiente

Lógica de ajuste

''' ¿Glicemia preprandial alta? → Ajustar la insulina LENTA (NPH o glargina) del período anterior

¿Glicemia postprandial alta + preprandial normal? → Ajustar la insulina RÁPIDA (cristalina/ultrarápida) de ESA comida '''

Casos tipo

TABLA 6.5.2: CASO VS GLICEMIA ALTA		
CASO	GLICEMIA ALTA	AJUSTE
DM1 esquema intensificado, post-desayuno ↑ + post-almuerzo ↑	Post-comidas	↑ cristalina pre-desayuno y pre-almuerzo
DM1 todas las glicemias altas	Pre y post comidas	↑ glargina (ultralenta basal) primero; luego ver postcomidas
DM2 solo NPH nocturna, pre-desayuno alto	Pre-desayuno	↑ NPH nocturna
DM2 dos dosis NPH, pre-almuerzo y pre-cena altos	Precomidas tarde	↑ NPH matinal
DM2 dos dosis NPH, post-almuerzo y post-cena altos, pero precomidas normales	Post-almuerzo y post-cena	Agregar cristalina pre-almuerzo y pre-cena

Objetivo de control (HbA1c)

TABLA 6.5.3: PACIENTE VS OBJETIVO HBA1C			
PACIENTE	OBJETIVO HBA1C		
DM general	< 7%		
Hipoglicemias - Generalidades	Hipoglicemias frecuentes, niño pequeño, > 75 años, esperanza de vida < 10 años	>	< 8%

Glicemias individuales (orientadoras)

- Pre-prandial: < 100–130 mg/dL
- Post-prandial: < 130–180 mg/dL
- **Manda la HbA1c** — una postprandial alta sola no obliga a ajuste si la HbA1c está bien

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Hombre de 64 años con DM2 en esquema NPH nocturna (22:00h) presenta glicemias en ayunas elevadas (190-210 mg/dL). Se realiza control a las 03:00 AM que muestra glicemia de 55 mg/dL."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Efecto Somogyi: hipoglicemia nocturna (03:00 AM) que genera rebote hiperglicémico matinal por liberación de hormonas contrarreguladoras (cortisol, adrenalina). Conducta: REDUCIR la dosis de insulina NPH nocturna o dar colación antes de dormir. Diferenciar del Fenómeno del Alba (03:00 AM normal/alta), donde se debe AUMENTAR la NPH nocturna.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- NPH nocturna determina glicemia predesayuno. NPH matinal determina prealmuerzo y presena.
- Insulinas rapidas determinan glicemias postprandiales. Postprandiales tambien dependen de preprandial y comida.
- Si todo esta alto: primero arreglar basales (subir ultralenta/NPH), luego ajustar rapidas.
- Si solo postprandiales estan altas con precomidas normales: subir rapida de ese horario.
- Hipoglicemia con buen control: agregar colacion o bajar insulina segun contexto.
- En adultos mayores con HbA1c bajo 8%: no hacer ningun cambio aunque glicemias individuales esten altas.
- La HbA1c manda sobre las glicemias individuales para tomar decisiones de ajuste.
- Costo del buen control metabolico: hipoglicemias y alza de peso.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (AJUSTES DE INSULINA)

PREGUNTA 1

Paciente con DM1 en esquema intensificado, HbA1c 8%. Glicemias precomida normales pero postdesayuno en 260 y postalmuerzo en 200. ¿Cual es la conducta?

- A)** Subir la dosis de insulina glargina
- B)** Subir insulina rapida predesayuno y prealmuerzo
- C)** Agregar NPH matinal
- D)** No hacer cambios
- E)** Cambiar a bomba de insulina

PREGUNTA 2

Paciente de 82 anos con DM2, dos dosis de NPH, HbA1c 7.5%. Varias glicemias individuales estan entre 150-200. ¿Cual es la conducta?

- A)** Subir ambas dosis de NPH
- B)** Agregar insulina cristalina precomida
- C)** No hacer ningun cambio
- D)** Bajar las dosis de NPH
- E)** Cambiar NPH por glargina

PREGUNTA 3

Paciente con DM2, dos dosis de NPH, HbA1c 8.5%. Las glicemias precomida estan normales pero las postalmuerzo y postcena estan elevadas. ¿Que insulina hay que agregar?

- A)** Subir NPH nocturna
- B)** Subir NPH matinal
- C)** Insulina cristalina prealmuerzo y presena
- D)** Cambiar a esquema intensificado con glargina
- E)** Agregar metformina

RESUMEN: AJUSTES DE INSULINA

El ajuste de insulino terapia se basa en entender que las insulinas lentas (NPH, ultralentas) determinan las glicemias preprandiales, y las insulinas rapidas (cristalina, ultrarrapidas) determinan las postprandiales. Cuando hay hipoglicemia se baja la insulina o se agrega comida; cuando la HbA1c esta alta se sube la insulina o se baja la comida. La NPH nocturna determina la glicemia predesayuno. La NPH matinal determina la prealmuerzo y presena. Las rapidas precomida determinan las postcomidas respectivas. Las postprandiales tambien dependen de la preprandial y de la comida consumida. En los ejercicios: si solo las postprandiales estan altas con preprandiales normales, subir las rapidas de ese horario. Si todo esta alto, primero arreglar las basales subiendo la ultralenta, y luego ajustar rapidas si persisten postprandiales altas. Si hay hipoglicemias con buen control, agregar colacion o bajar insulina segun contexto. En adultos mayores con HbA1c bajo 8%, no cambiar nada. Si las postcomidas estan mal con precomidas buenas, agregar cristalina.